

TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL

Miguel Rodríguez Alonso, Raúl López Izquierdo.

INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa superficial (TVS) es una inflamación de una o más venas del sistema venoso superficial, debido a la presencia de un trombo en su interior; se trata de una patología muy frecuente, se calcula que la prevalencia en la población general se sitúa entre el 3-11% siendo más frecuente en mujeres y aumentando su incidencia con la edad.

Generalmente afecta a venas varicosas (70%), aunque también puede desarrollarse sobre venas sanas, sin ninguna patología de base, en cuyo caso habría que sospechar alguna patología subyacente entre las que destacan las enfermedades autoinmunes, distintos trastornos hematológicos, patología cancerosa (síndrome de Trousseau) o estados infecciosos que favorezcan la trombofilia.



La mayoría de las TVS se desarrollan sobre varices, especialmente sobre la vena safena interna.

La safena interna es la vena sobre la que asientan entre el 60-80% de las trombosis venosas superficiales aunque puede desarrollarse en otras localizaciones anatómicas como: cuello, miembros superiores (asociadas a la iatrogenia producida por el uso de vías venosas), la región inguinal o la pared anterior del tórax y abdomen, en este último caso la afectación de los plexos venosos epigástricos, mamarios y axilares se conocen como **enfermedad de Mondor**.



Las TVS en extremidades superiores se asocian al uso de vías venosas.

Clásicamente la TVS se ha considerado una enfermedad benigna. Sin embargo, pueden asociarse a una serie de **complicaciones** entre las que destacan:

- La trombosis venosa profunda (TVP) (20%).
- El tromboembolismo pulmonar (4%) y/o
- Complicaciones sépticas (fundamentalmente en trombosis que afectan a miembros superiores).

Los factores de riesgo para el desarrollo de un trombo en el sistema venoso profundo a partir de una TVS dependen del tamaño y localización del trombo así como de factores intrínsecos al paciente:

- Trombos de un tamaño ≥ 5 cm.
- Trombos a ≤ 5 cm del sistema venoso profundo
- Presencia de trombofilia, neoplasia maligna, terapia con estrógenos o cualquier otra patología asociada.

DIAGNÓSTICO

Esta entidad, rara vez cursa de forma asintomática por lo que el diagnóstico de presunción se basa en la elaboración de una buena anamnesis, que debería reflejar los antecedentes personales, el motivo de consulta, así como la sintomatología específica (inflamación y dolor en el tramo venoso afectado) y la presencia o no de síntomas asociados con las posibles complicaciones que se pueden presentar. En la exploración física, la existencia de un cordón fibroso, junto a dolor, eritema y edema en la zona afectada es suficiente para establecer el diagnóstico. El empleo de pruebas como el eco-doppler, si bien no es imprescindible, puede ser interesante en caso de duda diagnóstica y ayuda a conocer la magnitud de la trombosis, los segmentos de vena trombosados y el funcionamiento de la circulación venosa. En los casos que la trombosis venosa superficial afecte a la totalidad de la vena safena interna, a todo un paquete venoso o sospechemos la existencia de alguna complicación de las mencionadas, se debería solicitar una **analítica sanguínea**:

- Hemograma con fórmula leucocitaria.
- Coagulación básica con determinación del Dímero-D.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirrubina, PCR.
- Eco-doppler si duda diagnóstica.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento de esta entidad se basa en aliviar el dolor, impedir la extensión del trombo, prevenir las complicaciones tromboembólicas y evitar su recidiva.

- Recomendaciones generales al paciente. Frío local para controlar el dolor y la inflamación.
- Movilización precoz.
- Control del dolor o inflamación: ibuprofeno 600mg 1 cada 8h o diclofenaco 50mg 1 cada 8h o dexketoprofeno 25mg 1 cada 8h o tramadol 50mg 1 cada 8h si dolor.
- Medias de compresión elástica o vendaje compresivo de la extremidad afectada.
- Si TVS recurrente FONDAPARINUX 2,5 mg subcutáneo cada 24h hasta valoración por cirugía vascular.
- Si signos de linfangitis o infección asociada: cloxacilina 500mg 1 cada 6h durante 7 días o clindamicina 300mg 1 cada 8h durante 7 días o amoxicilina/ácido clavulánico 875/125mg 1 cada 8 horas durante 7 días.
- Consultar con cirugía vascular y/o derivación a cirugía vascular si la extensión es muy grande o existe el riesgo de desarrollar un trombo en el sistema venoso profundo.

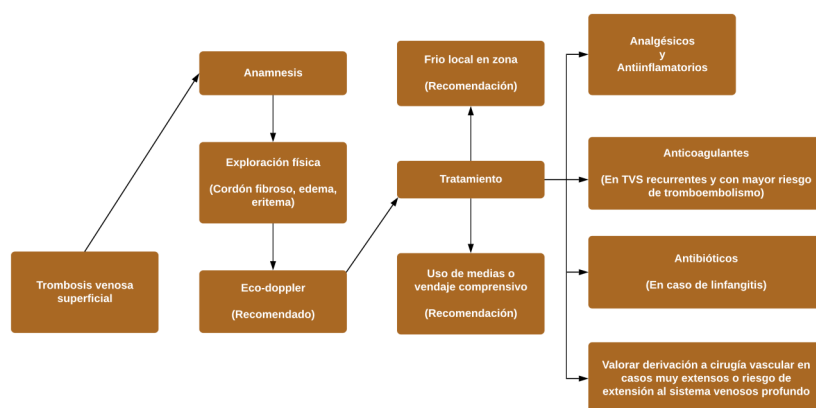
Se deben hacer una serie de recomendaciones para el paciente, como es el uso de frío local para controlar el dolor y la inflamación y el uso de medias de compresión elástica o un vendaje compresivo de la extremidad lo que va a favorecer el retorno venoso. Desde un punto de vista farmacológico, el tratamiento incluye fundamentalmente analgésicos y antiinflamatorios. El uso del tratamiento anticoagulante se debería recomendar en el caso de aquellos pacientes con una TVS recurrente y en los que presenten riesgo de desarrollar una TVP. Se inicia con HBPM:

Fondaparinux 2,5mg subcutáneo cada 24h hasta valoración por cirugía vascular. Si se observan signos de linfangitis o infección asociada se podría iniciar un tratamiento antibiótico: cloxaciclina, clindamicina, amoxi-clavulánico. En algún caso si la extensión es muy grande o existe el riesgo de desarrollar un trombo en el sistema venoso profundo es necesaria consultar con cirugía vascular y/o derivación a cirugía vascular.

ALERTA DE LA PATOLOGÍA

La TVS suele ser, en principio, una patología banal y de curso autolimitado. Sin embargo, no se debe olvidar que en un porcentaje de casos pueden desarrollar complicaciones como trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares.

Cabe reseñar que en ocasiones, estas trombosis superficiales, pueden constituir la primera manifestación de otra enfermedad como son: el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Behcet, síndromes mieloproliferativos, hemoglobinuria paroxística nocturna o la enfermedad cancerosa entre otras.



BIBLIOGRAFÍA

- Decousus H, Frappé P, Accasant S, Bertolotti L, Buchmuller A, Seffert B et al. Epidemiology, diagnosis, treatment and management of superficial-vein thrombosis of the legs. *Best Pract Res Clin Haematol* .2012;25(3):275-284.
- Lozano Sánchez FS, González Porras JR, Zarco Castillo J, Alberca Silva I. La trombosis venosa superficial: ¿es una enfermedad benigna? *Angiología*.2011;63(1):25-30
- Leal Lorenzo JI, Flores Herrero A, Aguilar Florit J. Patología vascular periférica aguda. En: Julián Jimenez A. *Manual de protocolos y actuación en urgencias*. 3ª edición. Madrid: Edicomplet; 2010. p33-24.
- Horlait G, Bulpa P, Petit J. Superficial Venous Thrombosis. *MOJ Clin Case Rep*. 2017;6(4):101-102.
- Scovell S. Phlebitis and thrombosis of the superficial lower extremity veins. *Post TW*, ed. UpToDate. Waltham, MA. Disponible en: www.uptodate.com (Consultado en Mayo, 2018)